Клинические рекомендации

# Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит<br>**J32.1** — Хронический фронтальный синусит<br>**J32.2** — Хронический этмоидальный синусит<br>**J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит<br>**J32.4** — Хронический пансинусит<br>**J32.8** — Другие хронические синуситы<br>**J32.9** — Хронический синусит неуточненный<br>**J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 5

2.4 Клиническая картина 6

2.5 Жалобы и анамнез 7

**3. Диагностика** 8

3.1 Критерии диагноза 8

3.2 Осмотр оториноларинголога и консультации специалистов 8

3.3 Бактериологическое исследование 9

3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки 9

3.5 Компьютерная томография околоносовых пазух 9

**4. Лечение** 10

4.1 Базисная терапия 10

4.2 Симптоматическая терапия при обострении 10

4.3 Лёгкое обострение (0–3 балла по ВАШ) 11

4.4 Среднетяжёлое (4–7 баллов) и тяжёлое (8–10 баллов) обострение 11

4.5 Хирургическое лечение 12

4.6 Иное лечение 13

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 14**

5.1 Послеоперационное ведение 14

5.2 Профилактика 14

5.3 Организация медицинской помощи 15

5.4 Показания к госпитализации 15

5.5 Прогноз 15

**6. Источник и актуальность 15**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 16

## 1. Основные положения

- Диагноз хронического синусита у взрослых устанавливается при сохранении **двух симптомов и более** (обязательно заложенность носа или выделения из носа) **12 недель и более** и подтверждается эндоскопией или КТ (полные критерии во вкладке «Диагностика»).
- Основа консервативного лечения:
  1. промывание полости носа солевым раствором всем пациентам;
  2. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**; для оценки эффекта их применяют **не менее 3 месяцев**.
- К системной антибактериальной терапии прибегают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия.
- Детям при неэффективности консервативной терапии **в течение 3–6 месяцев**:
  1. при гипертрофии аденоидов III степени первым этапом удаление аденоидов;
  2. при среднетяжёлом и тяжёлом ХРС, если гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены **более 6 месяцев** назад, функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.
- Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение:
  1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
  2. тяжёлое обострение;
  3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
  4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- При случайном выявлении бессимптомной кисты околоносовой пазухи большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку многие кисты медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
- Мукоцеле растёт медленно, растягивает, а в ряде случаев разрушает стенку пазухи. Консервативному лечению оно не поддаётся, поэтому при выявлении показано плановое хирургическое лечение.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) — это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух длительностью **более 12 недель** с **двумя и более** симптомами.

**Симптомы**

1. заложенность носа или выделения из носа (передние или стекающие в носоглотку): один из них обязателен;
2. боль или ощущение давления в области лица;
3. снижение или потеря обоняния.

**Определения кист околоносовых пазух**

1. **Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты** формируются в результате обструкции выводных протоков желёз слизистой оболочки; стенки таких кист имеют двустороннюю выстилку мерцательным цилиндрическим эпителием.
2. **Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты** — доброкачественные образования, расположенные в толще слизистой оболочки, без внутренней эпителиальной выстилки; они возникают вследствие хронического воспаления в околоносовых пазухах или баротравмы.

Мукоцеле представляет собой доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование околоносовой пазухи. Оно формируется при стойком нарушении дренажной функции естественного соустья пазухи и часто вызывает растяжение, реже разрушение её стенок.

### 2.2 Этиология

**Заболевания, ассоциированные с ХРС**

1. аллергический ринит;
2. первичная цилиарная дискинезия;
3. муковисцидоз;
4. бронхиальная астма;
5. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
6. иммунодефицитные состояния;
7. системные аутоиммунные заболевания.

**Анатомические особенности остиомеатального комплекса**

1. искривление перегородки носа;
2. буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина;
3. гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки;
4. аномалии крючковидного отростка;
5. добавочное соустье верхнечелюстной пазухи.

Эти особенности нарушают вентиляцию полости носа и отток секрета из полости носа и околоносовых пазух. У детей, значительно реже у взрослых, ХРС может быть связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольного возраста, основной причиной ХРС является муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По данным отечественных исследований, связь между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не выявлена.

Предрасполагающим фактором может являться также аллергический отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с заболеваниями зубов и стоматологическим лечением; среди возбудителей преобладают анаэробы.

**Причины хронического верхнечелюстного синусита**

1. периодонтит или пародонтит;
2. эндодонтическое лечение (частая причина): инфицированный детрит или пломбировочный материал попадает в пазуху через корневые каналы;
3. дентальная имплантация с предшествующим наращиванием костной ткани.

ГЭРБ также может способствовать развитию ХРС: попадание рефлюктата на слизистую оболочку полости носа и носоглотки вызывает воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса, что может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важным фактором риска является курение: табак оказывает токсическое действие на слизистую оболочку полости носа, вызывает её сухость и изменяет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалительными заболеваниями полости носа и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты в большинстве случаев обусловлены хроническим, прежде всего аллергическим, воспалением слизистой оболочки; риск их развития повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста развивается из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба; зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё; фолликулярная киста развивается очень медленно из зубного фолликула.

В подавляющем большинстве случаев мукоцеле является следствием вмешательств на околоносовых пазухах.

**Другие причины мукоцеле**

1. травма;
2. хроническое воспаление пазух;
3. опухоли;
4. лучевая терапия.

Описаны врождённые мукоцеле. Более чем в трети случаев мукоцеле расценивается как идиопатическое, то есть причину установить не удаётся. У детей основной причиной является вторичный хронический синусит при муковисцидозе.

### 2.3 Классификация

**По локализации (с указанием стороны)**

1. верхнечелюстной;
2. этмоидальный;
3. фронтальный;
4. сфеноидальный.

Воспаление пазух только одной стороны обозначают как гемисинусит, поражение нескольких пазух как полисинусит.

В клинической практике хронический синусит принято подразделять на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По этиологии выделяют бактериальный, грибковый и бактериально-грибковый синусит.

Тяжесть оценивают по суммарной выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10:

1. лёгкая форма: **0–3 балла**;
2. среднетяжёлая: **4–7 баллов**;
3. тяжёлая: **8–10 баллов**.

> Классификация по тяжести содержит ссылку на приложение Г1, однако в нём описана ВАШ только для оценки интенсивности боли и с другой градацией: значение до 2 см соответствует слабой боли, 2–4 умеренной, 4–6 сильной, 6–8 сильнейшей, до 10 невыносимой. Способ подсчёта суммарной выраженности симптомов в рекомендации не указан.

Классификация EPOS 2020 года основана на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит может быть односторонним (локализованным), с воспалением 2-го типа или не 2-го типа; дополнительно выделяют аллергический грибковый синусит и изолированный синусит (название по поражённой пазухе). Первичный синусит может быть и двусторонним (диффузным) с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний синусит может быть механическим, воспалительным и иммунным; к его фенотипам относятся первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

В России кисты околоносовых пазух, как правило, классифицируют по М. И. Кадымовой:

1. ретенционные;
2. лимфоэктатические;
3. одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи;
4. кисты, связанные с пороками развития.

Более 90% кист локализуются в верхнечелюстной пазухе, около 5% в клиновидной пазухе, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта кисты встречаются крайне редко. Более чем в 80% случаев киста односторонняя; множественные кисты выявляются лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; ряд авторов считает наиболее частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны также крайне редкие локализации: нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

### 2.4 Клиническая картина

Клиническая картина ХРС неспецифична:

1. заложенность носа;
2. выделения из носа и стекание по задней стенке глотки;
3. головная или лицевая боль;
4. снижение или отсутствие обоняния;
5. ощущение неприятного запаха в носу;
6. у детей кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки.

Основные симптомы, в наибольшей степени влияющие на самочувствие, это заложенность носа и выделения. Хронический синусит отличается от острого сохранением симптомов **более 12 недель** без полного их разрешения.

Кисты часто протекают бессимптомно и выявляются случайно при лучевом исследовании головы.

**Крупная киста проявляется**

1. чаще всего головная или лицевая боль;
2. редко внезапное истечение из носа жидкости янтарного цвета при самопроизвольном разрыве кисты;
3. онемение верхней губы или зубная боль.

Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, вероятнее всего, обусловлены сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от локализации и размера.

**Основные симптомы мукоцеле**

1. головная боль;
2. ощущение давления в области лица;
3. заложенность носа;
4. выделения из носа;
5. боль в периорбитальной области.

Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, однако значительно реже, чем киста.

### 2.5 Жалобы и анамнез

**Жалобы взрослых**

1. стойкая односторонняя или попеременная заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения;
3. необходимость сморкания или стекание слизи по задней стенке глотки, более выраженное после пробуждения или постоянное в течение дня;
4. неприятный запах в полости носа или носоглотке;
5. снижение обоняния вплоть до аносмии;
6. при хроническом сфеноидите периодическая боль в теменной и затылочной областях.

Для хронического фронтита характерна выраженная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Возможно ощущение давления за спинкой носа и глазными яблоками, усиливающееся при обострении.

У детей младшего возраста жалобы выясняют у родителей или опекунов:

1. частые затяжные «насморки»;
2. заложенность носа;
3. слизистые выделения;
4. кашель, преимущественно ночью или в положении лёжа на спине.

При выявлении кистоподобного образования по данным лучевых исследований в первую очередь уточняется наличие головной или лицевой боли, её постоянный характер, провоцирующие и усиливающие её факторы. Выясняются перенесённые ранее операции на полости носа и околоносовых пазухах и стоматологическое лечение.

## 3. Диагностика

### 3.1 Критерии диагноза

**Обязательные критерии**

1. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа (затруднение носового дыхания) или выделения из носа, передние или стекающие по задней стенке глотки;
2. сохранение симптомов **12 недель и более**.

**Возможные симптомы**

1. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
2. снижение или потеря обоняния.

**Подтверждение диагноза**

1. эндоскопия: полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе;
2. компьютерная томография (КТ): изменения слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух.

У детей необходимы **два и более** из четырёх симптомов на протяжении **12 недель и более**:

1. затруднение носового дыхания;
2. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
3. выделения из носа или стекание по задней стенке глотки;
4. кашель.

Эндоскопические признаки и изменения по данным КТ такие же, как у взрослых.

**Киста околоносовой пазухи: признаки на КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ)**

1. округлое однородное мягкотканное образование на широком основании;
2. чёткие границы;
3. отсутствие деструкции кости и выраженной деформации стенок.

Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

**Одонтогенная киста верхнечелюстной пазухи: признаки на КТ**

1. однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи;
2. чёткие границы, оболочка костной плотности;
3. связь с корнями верхних зубов.

Учитывают заключение стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о заболевании соседних зубов.

**Мукоцеле: признаки на КТ**

1. образование в пазухе с округлым ровным контуром;
2. однородное содержимое без кальцинатов и включений;
3. возможны истончение прилежащих костных структур и пролабирование в соседние анатомические области.

### 3.2 Осмотр оториноларинголога и консультации специалистов

Всех пациентов с хроническим синуситом, с подозрением на кисту или мукоцеле осматривает оториноларинголог: собирает жалобы и анамнез, планирует лечение.

**Консультация аллерголога**

1. хронический синусит и отягощённый аллергологический анамнез;
2. взрослые с подозрением на кисту или мукоцеле и отягощённым аллергологическим анамнезом.

**Консультация гастроэнтеролога**

1. симптомы рефлюкса.

**Консультация генетика**

1. признаки муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии.

**Консультация стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга**

1. подозрение на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи: подтверждение или исключение одонтогенной причины.

### 3.3 Бактериологическое исследование

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности.

**Показания**

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. обострение: выбор или коррекция антибактериальной терапии.

Оптимальным материалом для исследования является аспират непосредственно из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или интраоперационно.

### 3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом: оценивает синоназальные структуры и подтверждает диагноз.

**Диагностические признаки**

1. полипы;
2. слизисто-гнойные выделения;
3. отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе.

### 3.5 Компьютерная томография околоносовых пазух

**Показания к спиральной КТ околоносовых пазух**

1. признаки осложнений при обострении;
2. подготовка к хирургическому вмешательству;
3. необходимость дифференциальной диагностики.

КТ является наиболее информативным методом как у взрослых, так и у детей.

**Диагностические признаки**

1. типичные признаки ХРС: утолщение слизистой оболочки и снижение пневматизации в области соустий;
2. изолированное воспаление;
3. блок соустья;
4. инородное тело;
5. диффузный грибковый процесс или мицетома;
6. опухоль;
7. аномалии развития пазух;
8. признаки одонтогенной причины.

Для планирования объёма операции используют КТ давностью **не более 6 месяцев**.

**Показания**

1. подозрение на кисту, выявленную другим методом и сопровождающуюся постоянными или периодическими симптомами;
2. подозрение на мукоцеле.

При затруднении дифференциальной диагностики мукоцеле с другими образованиями КТ выполняется с внутривенным болюсным контрастированием: контрастное вещество накапливается в оболочке мукоцеле, но не в его содержимом.

---

## 4. Лечение

Этиологических факторов ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основой консервативного лечения является медикаментозная терапия; по показаниям её назначают и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательства эффективности консервативного лечения кист и мукоцеле околоносовых пазух отсутствуют; уменьшение симптомов возможно лишь при эффективности медикаментозной терапии сопутствующего ХРС или аллергического ринита.

### 4.1 Базисная терапия

1. Промывание полости носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором всем пациентам: очищает полость носа и уменьшает антигенную нагрузку на слизистую оболочку.
   Промывание полости носа имеет важное значение и в составе послеоперационного лечения.
2. Интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС) пациентам **старше 12 лет** для уменьшения выраженности симптомов.
   Единая схема дозирования, кратности и длительности применения отсутствует; допустимо применение как низких, так и высоких доз. Для оценки эффекта лечение продолжается **не менее 3 месяцев**.
   Носовые кровотечения вследствие сухости слизистой оболочки чаще при высоких дозах.

   **Зарегистрированное показание при ХРС есть только у мометазона, назальный спрей**

   1. взрослые и дети старше 12 лет: по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, 400 мкг в сутки.

### 4.2 Симптоматическая терапия при обострении

1. Сосудосуживающие капли или спреи в нос для облегчения оттока секрета из пазух, **не более 5–7 дней**.
   1. нафазолин в оториноларингологической практике не допускается: выраженное токсическое действие;
   2. предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%;
   3. строго по назначению и под контролем врача, **не более 5–7 дней**: при более длительном применении развивается медикаментозный ринит.
2. Растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием для более быстрого регресса симптомов.
   Эффективны комбинированные препараты, содержащие экстракты корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.
3. Муколитические препараты для разжижения отделяемого и облегчения его оттока.
   1. карбоцистеин коротким курсом, **до 2–3 недель**, при обострении с густым секретом в полости носа;
   2. возможны курсы около 3 месяцев в сочетании с противовоспалительными средствами;

3. одновременно с другими отхаркивающими и муколитическими средствами, в том числе местными, не назначают: усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

4. Нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол при повышении температуры тела, головной или лицевой боли.
   Детям **до 6 лет** допустимы только:
   1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки;
   2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки.

### 4.3 Лёгкое обострение (0–3 балла по ВАШ)

1. Пациентам, ранее перенёсшим синусотомию, при появлении гнойных выделений: местные антибактериальные препараты.
   Эффект оценивается **через 3–4 дня**; при его отсутствии решается вопрос о системной антибактериальной терапии.

   **Зарегистрированы в России для лечения ХРС**
   1. фрамицетин, назальный спрей: детям с первых лет жизни; при обострении **не более 7 дней**;
   2. комбинированный спрей (дексаметазон, неомицин, полимиксин B, фенилэфрин): **с 2,5 лет**; при обострении **не более 10 дней**.

   Разовая и суточная дозы строго по инструкции.

   Введение в полость носа и околоносовые пазухи растворов антибиотиков, предназначенных для внутримышечного и внутривенного введения, не допускается: они не адаптированы для этой цели и оказывают повреждающее действие на мерцательный эпителий. Для введения в пазуху может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

### 4.4 Среднетяжёлое (4–7 баллов) и тяжёлое (8–10 баллов) обострение

1. Системная антибактериальная терапия: при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с заболеваниями, повышающими риск бактериальной инфекции. Стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой (препараты и дозы в таблице ниже).
2. Эффект антибиотика должен проявиться **на третьи сутки**; при наличии эффекта препарат применяют **10–14 дней**.
3. Если стартовый антибиотик в амбулаторных условиях неэффективен, решают вопрос о неотложном направлении в оториноларингологическое отделение. В стационаре при среднетяжёлом течении предпочтителен приём препаратов внутрь, при его невозможности парентеральное введение; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.
4. При неэффективности цефалоспоринов III поколения или выделении устойчивых к ним штаммов: препарат резерва (цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие) с учётом чувствительности возбудителя.
5. Детей с обострением, требующим системных антибиотиков, при невозможности назначения пенициллинов предпочтительно лечить в стационаре.
6. Пункция верхнечелюстной пазухи для дренирования: при тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, при среднетяжёлом в случае неэффективности консервативного лечения.
   Через пункционную иглу промывают пазуху раствором антисептика, удаляют секрет и вводят антибиотик.
   Пункция допустима только при наличии результатов лучевого исследования, исключающих гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и подтверждающих скопление в ней секрета.
   При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию выполняют только в условиях стационара.
   Для дренирования возможны установка синус-катетера или зондирование пазух через естественные соустья.

**Системные антибиотики**

| Препарат | Показания и режим дозирования |
|---|---|
| **Амоксициллин и клавулановая кислота** | Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых.<br>1. дети от 3 месяцев до 12 лет или с массой тела **менее 40 кг**, суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл: 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов;<br>2. те же дети, суспензия 400/57 мг в 5 мл: 45 мг/кг в сутки в 2 приёма;<br>3. высокий риск инфекции, вызванной полирезистентным пневмококком: суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма;<br>4. дети с массой тела **более 40 кг** и пациенты **старше 12 лет**: таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. |
| **Цефиксим** | При лёгкой аллергии на пенициллины.<br>1. дети **младше 12 лет** или с массой тела **менее 50 кг**: 8 мг/кг в сутки в 1 приём;<br>2. пациенты **старше 12 лет**: 400 мг 1 раз в сутки. |
| **Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим** | При неэффективности амоксициллина с клавулановой кислотой.<br>1. пациенты **старше 12 лет** или с массой тела **от 50 кг**: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки; цефтриаксон в/в или в/м 1–2 г 1 раз в сутки; цефотаксим в/в или в/м 1 г каждые 12 часов;<br>2. дети **младше 12 лет** или с массой тела **менее 50 кг**: цефиксим 8 мг/кг в сутки в 1 приём; цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки в 1 введение; цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения. |
| **#Левофлоксацин, #моксифлоксацин** | Только взрослым пациентам в амбулаторных условиях при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курс **10–14 дней**. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции. |

### 4.5 Хирургическое лечение

**Порядок хирургического лечения (экстренный, неотложный, плановый)**

1. тяжёлое обострение, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями: неотложное или экстренное вмешательство;
2. среднетяжёлое обострение и неэффективность консервативного лечения: возможны малоинвазивные манипуляции в неотложном порядке;
3. остальные пациенты: плановое вмешательство по показаниям; при отсутствии показаний или наличии противопоказаний консервативное лечение и наблюдение оториноларинголога.

1. Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии: функциональная риносинус-хирургия для восстановления аэрации пазух, устранения симптомов и предотвращения осложнений.
2. Детям с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени при неэффективности консервативного лечения **в течение 3–6 месяцев**: первым этапом удаление аденоидов.
   Вмешательство планируют при отсутствии противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в условиях оториноларингологического отделения или стационара кратковременного пребывания; при наличии соответствующего оснащения вмешательство проводится под эндоскопическим контролем.
3. Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС при неэффективности лечения **в течение 3–6 месяцев**, если гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены **более 6 месяцев** назад: функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.
   Операция плановая. Вмешательство не нарушает рост пазух и лицевого скелета, однако у детей выше риск рубцевания и повторного стенозирования, а малые размеры анатомических структур требуют современного оборудования.

4. Детям с изолированным поражением пазухи: эндоскопическое дренирование пазухи.

   **Детям операцию выполняют независимо от состояния аденоидов, если**

   1. на КТ отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации;
   2. в сочетании с типичными жалобами.

   У детей необходима онкологическая настороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, не увеличивающихся в размерах.

5. Киста околоносовой пазухи с постоянными или периодическими симптомами: эндоскопическое удаление с опорожнением кисты и полным или частичным удалением её оболочки.
   При случайном выявлении бессимптомной кисты большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку кисты, за исключением одонтогенных, часто медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
6. Мукоцеле: эндоскопическое дренирование у всех пациентов.
   При лобной локализации методом выбора считается эндоскопическая марсупиализация с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении мукоцеле, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле с распространением в полость черепа используется наружный доступ.

> В тексте рекомендации имеется расхождение: в рекомендации о хирургическом лечении взрослых показанием является неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, тогда как в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Под функциональной риносинус-хирургией в рекомендации понимаются фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, гайморотомия и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых при наличии соответствующего оснащения предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановом вмешательстве она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют в плановом порядке, как правило, теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи в ряде случаев используются микрогайморотомия и фронтотомия через переднюю стенку.

### 4.6 Иное лечение

Пациенты с вторичным ХРС, у которых изменения в полости носа и околоносовых пазухах являются проявлением другого заболевания, находятся под наблюдением и получают лечение у профильного специалиста. Лечение одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи осуществляют совместно со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Послеоперационное ведение

После операции все пациенты находятся под амбулаторным наблюдением оториноларинголога для оценки состояния полости носа и своевременного выявления поздних осложнений.

Первый осмотр **через 7–14 дней** после выписки, далее повторно несколько раз в течение года.

**Цели осмотров**

1. контроль состояния полости носа: при неадекватном уходе образуются корки и синехии;
2. выявление и предупреждение осложнений;
3. выполнение манипуляций при необходимости;
4. контроль течения заболевания и своевременная коррекция лечения.

**В течение месяца** после операции щадящий режим; избегать факторов, повышающих давление и способных спровоцировать кровотечение:

1. интенсивных физических нагрузок;
2. перегревания;
3. переохлаждения.

Для профилактики острой респираторной инфекции избегать мест массового скопления людей, по возможности больше времени проводить дома.

### 5.2 Профилактика

Первичная профилактика: защита от неблагоприятных факторов внешней среды; вторичная: максимально раннее выявление заболевания.

**Профилактике способствуют**

1. своевременное лечение заболеваний зубов;
2. лечение гастроэзофагеального рефлюкса;
3. отказ от курения;
4. техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Формирование мукоцеле предупреждает соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на полости носа и околоносовых пазухах. Риск лимфоэктатических кист снижает своевременное лечение хронического воспаления в полости носа, а радикулярных одонтогенных кист — своевременное лечение заболеваний верхних зубов.

**Пациенту разъясняют**

1. полное излечение затруднительно, но выраженность симптомов можно уменьшить;
2. как правило, требуется пожизненный контроль;
3. тактику лечения определяет оториноларинголог, в ряде случаев совместно с другими специалистами.

**Образ жизни и лечение**

1. отказ от курения или по крайней мере уменьшение количества сигарет;
2. при аллергии гипоаллергенный быт;
3. приверженность лечению и соблюдение режима дозирования;
4. правильная техника введения препаратов и промывания полости носа.

### 5.3 Организация медицинской помощи

Лечение ведёт прежде всего оториноларинголог, при необходимости совместно с:

1. аллергологом-иммунологом;
2. гастроэнтерологом;
3. ревматологом;
4. стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

### 5.4 Показания к госпитализации

**Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение**

1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
2. тяжёлое обострение;
3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Показания к плановой госпитализации для хирургического лечения:

1. подтверждённый хронический синусит, резистентный к адекватной консервативной терапии **в течение 6 месяцев**;
2. рецидив симптомов после операции;
3. сохранение жалоб и признаков синусита у детей после удаления аденоидов;
4. изолированное воспаление с субтотальным или тотальным снижением пневматизации по данным КТ **более 2 месяцев**;
5. подозрение на новообразование пазухи неясного характера;
6. «синдром молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи по данным КТ;
7. киста с постоянными или периодическими симптомами;
8. мукоцеле.

Пациента выписывают:

1. после выполнения операции в запланированном объёме;
2. при удовлетворительном общем состоянии;
3. при отсутствии местного или системного острого инфекционно-воспалительного процесса.

### 5.5 Прогноз

**Эффективность лечения зависит от**

1. анатомических особенностей полости носа и околоносовых пазух;
2. хронических системных заболеваний;
3. активного и пассивного курения;
4. профессиональных вредностей;
5. климатических и экологических условий;
6. приверженности пациента лечению.

Одонтогенные кисты не регрессируют самостоятельно, и их лечением совместно занимаются несколько специалистов.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Хронический синусит» |
| Версия | 1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025 |

| | |
|---|---|
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года |
| Код в рубрикаторе | 955_1 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки хирургического лечения у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии операция показана после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации (раздел 6) после 6 месяцев неэффективной терапии.
- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, в котором описана ВАШ только для оценки боли и с другой градацией.